Soplos y valvulopatías

SEMIOLOGIA · Clase 03 · las 4 lesiones del corazón izquierdo, de la válvula al signo

1 · QUÉ FALLA: ESTENOSIS O INSUFICIENCIA, Y POR QUÉ SE OYE

Fiebre reumática F3
causa más común de lesión valvular adquirida: 75–85 % de las estenosis mitrales; sigue la endocarditis. En la aórtica: bicúspide, calcificación senil (mayor de 65 años), sífilis, disección

cicatriza la válvula y deja una

Valvulopatía
la válvula falla de dos maneras y la cavidad de atrás sufre

si el orificio se estrecha

si la válvula no cierra

Estenosis
la válvula no abre: la sangre pasa con dificultad hacia adelante y la presión sube detrás

Insuficiencia
la válvula no cierra: la sangre regurgita hacia atrás

Soplo funcional F17 · F18
válvulas sanas con flujo aumentado: suele ser sistólico, débil y sin frémito. Causas: anemia (menos viscosidad), hipertiroidismo y fiebre (más velocidad), ejercicio

también genera

por eso no indica lesión:

frena el flujo y crea

deja volver la sangre y crea la

Turbulencia
la sangre cruza un orificio alterado y se arremolina: la vibración se oye como soplo

Sin lesión valvular: el soplo se explica por el flujo, no por la válvula

2 · CÓMO SE DESCRIBE UN SOPLO: MOMENTO, FOCO, INTENSIDAD Y TIMBRE

Describir el soplo F2
situación en el ciclo, foco, irradiación, intensidad y timbre; además respiración, posición y ejercicio

empieza por la

sigue con foco, irradiación y

gradúa la intensidad con la

la desenmascara con

1 · Situación en el ciclo F1
sístole o diástole (proto, meso, tele u holo); se temporiza palpando la carótida

2 · Foco, irradiación y timbre F2
mitral en la punta (irradia a axila y dorso); aórtico en la base (irradia al cuello; la insuficiencia aórtica, al ápex). Timbre: aspirativo (IA), rudo (EA), áspero (EM)

4 · Intensidad: escala de Levine F13
I a VI: I muy débil, II débil, III moderado, IV fuerte, V fortísimo, VI audible sin tocar la piel; el frémito se palpa desde el grado IV

Maniobras
decúbito de Pachón (lateral izquierdo) refuerza los de la punta; sentado e inclinado hacia adelante, los de la base

si cae en la sístole

si cae en la diástole

si ocupa las dos fases

con el foco señala la

el frémito se suma a la

revelan el soplo oculto y la

Sistólicos F1
eyección mesosistólico (estenosis aórtica y pulmonar) o regurgitación holosistólico (insuficiencia mitral y tricuspídea, CIV)

Diastólicos F1
llenado en ruflar (estenosis mitral y tricuspídea) o regurgitación aspirativo (insuficiencia aórtica y pulmonar)

Soplo continuo F14
ocupa sístole y diástole sin interrupción y cubre R1 y R2: «en maquinaria», como el ductus arterioso persistente

por frecuencia y timbre orienta a la

como en el ductus, orienta a la

por dirección y duración orienta a la

Momento, foco, intensidad y timbre identifican la válvula y la lesión

para identificarla se hace la

si no sigue ninguna fase

su ejemplo congénito es la

en la mitral produce la

en la aórtica reduce el área:

3 · MITRAL: LA AURÍCULA IZQUIERDA PAGA

en la mitral reduce el

Estenosis mitral
área normal 4–6 cm²; da clínica cuando baja a 1–1,5 cm²

el flujo turbulento da el

hacia adelante: menor llenado y

hacia atrás dilata la

Ruflar diastólico en la punta
con refuerzo presistólico, mejor en decúbito de Pachón: reconoce la estenosis mitral

Pulso pequeño F4
pasa poca sangre al ventrículo y baja el débito: PA convergente

Aurícula izquierda dilatada
su presión sube de 10 a 25–35 mmHg

se transmite al pulmón como

pierde el ritmo y entra en

Congestión pulmonar
la presión se transmite hacia atrás: disnea progresiva hasta edema agudo

Fibrilación auricular F5
la aurícula dilatada pierde el ritmo: pulso irregular y palpitaciones; la arritmia más frecuente

estanca la sangre y forma

al cronificarse produce

Trombos intraauriculares F6
la aurícula ya no se contrae: la sangre se estanca y coagula

Hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca
final común de las lesiones mitrales

si se sueltan dan

Embolias sistémicas
los trombos se sueltan hacia el cerebro y otros órganos

Insuficiencia mitral
reflujo del ventrículo a la aurícula durante la sístole; lo regurgitado se suma al retorno pulmonar

también dilata la

se ausculta como

se tolera en silencio por la

Holosistólico en la punta
irradiado a axila y dorso: reconoce la insuficiencia mitral

Latencia
la aurícula tolera el reflujo: síntomas 6–10 años después de la fiebre reumática

la diferencial se cierra:

4 · AÓRTICA: EL VENTRÍCULO PAGA Y EL PULSO HABLA

Estenosis aórtica
área normal 3,5–4 cm²; da gradiente al reducirse a la mitad. Soplo mesosistólico rudo en la base, irradiado al cuello

en la aórtica produce la

la obstrucción provoca la

Hipertrofia concéntrica del VI
empuja contra la válvula estrecha: presión sistólica hasta cerca de 250 mmHg

a la periferia llega un

el miocardio hipertrofiado da la

Pulso parvus F7
sale poca sangre por latido

Triada
angina, síncope de esfuerzo y disnea (tardía, de mal pronóstico)

con diferencial pequeña da la

puede culminar en

PA convergente F7
diferencial menor de 30 mmHg: estenosis mitral y aórtica, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías

La más peligrosa y mortal
silente hasta que el área cae a la mitad; puede terminar en infarto o muerte súbita

Insuficiencia aórtica
regurgitación diastólica de la aorta al ventrículo, que se dilata; soplo protodiastólico aspirativo hacia el ápex

vacía la aorta en diástole:

PA divergente F8
sube la sistólica y cae la diastólica: p. ej. 140/30 (diferencial 110); extremo 140/0

en la femoral se oyen los

con el gran volumen da el pulso

Pulso céler o en martillo de agua F9
sube y cae muy rápido; también en ductus y fístulas arteriovenosas

Signos femorales F16 · F23
Duroziez: doble soplo, casi patognomónico; pistoletazo de Traube: ruido seco como un disparo (el banco escribe «Trousseau»)

su latido mueve la cabeza:

se ve latir en el cuello:

tiñe el lecho ungueal:

Musset F10
la cabeza se mueve en vaivén con cada latido

Quincke F11
el lecho ungueal enrojece y palidece; más claro al elevar la mano

Danza arterial F12
latidos amplios y visibles en el cuello (circulación hiperdinámica)

por la diferencial amplia reconoce la

por la diferencial amplia reconocen la

por la diferencial amplia reconoce la

por la diferencial amplia reconoce la

El cortejo periférico identifica la insuficiencia aórtica: todos nacen del pulso amplio y de la diferencial amplia

5 · OTROS RUIDOS: CONGÉNITOS Y FROTE

Frote pericárdico F19
roce de las hojas inflamadas, como cuero nuevo; no se irradia, no sigue una fase del ciclo y cambia con la posición

si desaparece

Si el frote desaparece, pensar en derrame, no en mejoría

CIV F15
la sangre pasa del VI al VD toda la sístole: soplo holosistólico, mejor en el xifoides, irradiado en faja

al pasar sangre oxigenada es

es uno de los cuatro defectos del

CIV acianótica F22
el cortocircuito lleva sangre ya oxigenada: no hay cianosis; es la congénita más frecuente

Tetralogía de Fallot F20
CIV, estenosis pulmonar, hipertrofia del VD y aorta cabalgante: la cardiopatía cianótica más frecuente

su aorta cabalgante mezcla y da

Sangre sin oxigenar a la aorta
la aorta recibe sangre de ambos ventrículos: cianosis desde el nacimiento

con el esfuerzo causa

Disnea paroxística, fatiga y crisis hipóxicas F20 · F21
el niño se alivia en cuclillas

por eso se indica la

El Fallot siempre necesita corrección quirúrgica

concepto · mecanismo · causa · desenlace · técnica · signo · complicación · síntoma · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología General — Aparato cardiovascular, tema 8 (2020); SOTITO 2018, Unidad I-2 — Valvulopatías y cardiopatías congénitas (clases 08h, 08d y 08e)